

La sphère respiratoire : pathologies et dysfonctionnements

Les infections et affections aiguës :

La **rhinite** et la **rhinopharyngite** sont les **affections les plus fréquentes de la sphère ORL**. Elles correspondent à une **inflammation des muqueuses nasales et pharyngées**, le plus souvent **d'origine virale**. Les muqueuses deviennent congestionnées, produisent un **excès de mucus et entraînent une obstruction nasale, des écoulements, des éternuements et parfois une légère fièvre**. Si elles ne sont pas correctement soignées, elles peuvent évoluer **vers une sinusite ou une otite**.

L'**angine** est une **inflammation aiguë du pharynx et des amygdales**. Elle est souvent d'origine virale, mais peut aussi être bactérienne (streptocoque). Elle se manifeste par une **gorge rouge et douloureuse, une fièvre, des difficultés à avaler et des ganglions cervicaux sensibles**.

La **bronchite aiguë** atteint les **grosses et moyennes bronches, souvent en extension à la trachée**. Elle se traduit par une **toux d'abord sèche puis grasse, avec production de crachats**.

Si la toux persiste plus de trois mois par an pendant plusieurs années, on parle de **bronchite chronique**, caractérisée par une **inflammation durable, un épaississement (fibrose) des tissus et une hypersécrétion de mucus**.

Les **pneumopathies** regroupent l'ensemble des **affections pulmonaires, quelle qu'en soit la cause (virale, bactérienne, allergique, parasitaire)**.

La forme aiguë d'origine bactérienne est appelée **pneumonie**. Elle se manifeste par une **fièvre élevée, une toux grasse, des douleurs thoraciques et une grande fatigue**. C'est une pathologie sérieuse qui nécessite une prise en charge rapide.

La **laryngite** touche le larynx et **provoque une inflammation de la muqueuse, souvent accompagnée d'une toux rauque, d'une gêne respiratoire et d'une voix enrouée**. Elle est fréquente chez l'enfant.

Les troubles chroniques et inflammatoires :

L'**asthme** est une **affection inflammatoire chronique des bronches**.

Il se caractérise par un **spasme des muscles bronchiques associé à une hypersécrétion de mucus**. Ce double mécanisme **réduit le diamètre des bronches, rendant la respiration difficile**, surtout à l'expiration. L'épithélium bronchique devient hyperréactif et les **glandes à mucus s'hypertrophient, formant parfois des bouchons qui obstruent les bronches**.

Les crises d'asthme peuvent être déclenchées par des **allergènes, un stress, un effort, des infections ou la pollution**.

La **bronchopathie chronique obstructive (BPCO)** associe une **bronchite chronique à un emphysème**. Elle résulte souvent du **tabagisme, de la pollution ou d'infections répétées**. Elle se traduit par une **toux productive, un essoufflement progressif et une fatigue importante**.

Les **allergies respiratoires** (comme la **rhinite allergique** ou l'**asthme allergique**) sont dues à une **hypersensibilité du système immunitaire face à des allergènes** (pollens, acariens, poussières). Elles se traduisent par des **éternuements, un nez bouché, des écoulements, une toux, voire une gêne respiratoire**.